

INFECÇÕES RESPIRATÓRIAS



ROTINA CLÍNICA

Material de apoio

RESFRIADO

- É a doença mais **frequente** no mundo industrializado.
- Incidência de 5 a 7 episódios/ano em pré-escolares e até 2 a 3 episódios/ano em adultos.
- **Etiologias:** Rinovírus (30 a 50%), Coronavírus, Influenza, Parainfluenza e Vírus sincicial respiratório.
- **Quadro clínico:** espirros, congestão nasal, rinorreia, odinofagia, tosse, cefaleia, febre e mialgia.



RESFRIADO

- **História natural:** doença **benigna, autolimitada**. O diagnóstico é clínico e o tratamento deve ser feito com sintomáticos sob demanda (conforme as principais queixas dos pacientes).
- **Observação:** é importante entender que o paciente pode apresentar quadro de tosse pós-infecciosa (duração pode se estender por até **8 semanas**) após resolução do resfriado. A fisiopatologia dessa condição envolve **hiperreatividade** das vias aéreas.



RESFRIADO

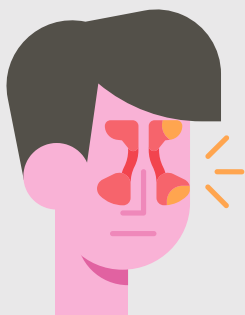
- A abordagem terapêutica envolve repouso, sintomáticos e orientações gerais, incluindo sobre possíveis sinais de alarme.
- **Detalhe:** Resultados do estudo OSAC trial sugerem **não haver benefício** na prescrição rotineira de corticoides pela via oral em adultos não asmáticos.

Atenção: demais detalhes do tratamento, tanto do resfriado, quanto das demais condições abordadas neste material, estão apresentados nos modelos de prescrição.



SINUSITE

- A rinossinusite é definida como uma doença **inflamatória** da **mucosa nasal** e dos **seios paranasais**.
- Infecções bacterianas representam de **2 a 10%** de todos os casos de rinossinusites infecciosas.
- A doença é extremamente comum, com registro de um episódio de rinossinusite anual a cada 7 pessoas (segundo literatura americana).



ROTINA CLÍNICA

SINUSITE

- Em relação à **sinusite bacteriana aguda**:
- **Etiologia:** *Streptococcus pneumoniae* e *Haemophilus influenzae* representam 75% dos casos, seguidos por *Moraxella catarrhalis*.
- **Quadro clínico:** descarga nasal anterior purulenta, descarga nasal posterior, congestão ou obstrução nasal, sensação de face congesta (plenitude facial), dor ou sensação de opressão em face, hiposmia ou anosmia, febre, cefaleia, tosse, dor auricular ou sensação de opressão nos ouvidos.



SINUSITE

- Lembre-se de que o **diagnóstico é clínico**. Não há necessidade de solicitar exame complementar nos pacientes com quadro não complicado.
- **Infectious Disease Society of America (IDSA)** sugere o diagnóstico de etiologia bacteriana nas seguintes situações: (1) Sintomas **persistentes** com duração maior que 10 dias, sem evidência de melhora clínica; (2) Sintomas **graves**, incluindo febre acima de 39 °C e descarga purulenta nasal por pelo menos 3 a 4 dias; (3) **Piora** de sintomas de um quadro inicialmente leve e que a princípio estava em melhora de pelo menos 5 a 6 dias de duração.



FARINGITE

- Definida como **processo inflamatório** na **faringe**, que causa desconforto ou dor de garganta.
- Cerca de 15 milhões de atendimentos ambulatoriais foram atribuídos à faringite em 2007 nos EUA.
- Apenas **5 a 15%** dos casos são secundários a estreptococo (principal causa bacteriana).
- Etiologias virais representam a maior parte dos casos, mas é importante saber reconhecer pacientes que apresentam provável etiologia bacteriana. Os critérios de **Centor** são úteis nesse cenário.



FARINGITE

- Critérios de Centor e Mclsaac:

<i>Critério</i>	<i>Variável</i>		<i>Ponto</i>
Centor	Febre >38°C		+1
	Ausência de tosse		+1
	Adenopatia cervical anterior		+1
	Exsudato ou edema amigdalano		+1
Mclsaac	Idade	3 a 14 anos	+1
		15 a 44 anos	0
		≥45 anos	-1

Probabilidade de faringite por Streptococcus do grupo A: ≤0 ponto: 1-2,5%; 1 ponto: 5-10%; 2 pontos: 11-17%; 3 pontos: 28-35%; ≥4 pontos: 51-53%

Racional: quanto **maior** for a pontuação, **maior** probabilidade de a etiologia ser bacteriana (Streptococcus do grupo A).



ROTINA CLÍNICA

PNEUMONIA

- Pneumonia é definida como aparecimento agudo de sintomas e sinais de infecção do **trato respiratório inferior**, sem outra causa óbvia, e associada a infiltrado pulmonar novo em exame de imagem.
- **Mortalidade em torno de 4 a 18%**, variando com idade, comorbidades e apresentação clínica (é a 3ª causa de morte no mundo e a mais comum causa de morte por doença infecciosa).
- No Brasil, cerca de 10 a 13% das internações hospitalares são por pneumonia (aproximadamente **1 milhão de internações por ano**).



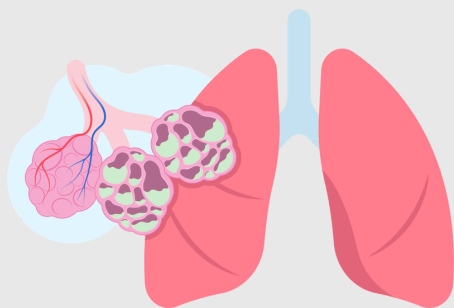
PNEUMONIA

- **Etiologia:** *Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae*, *Mycoplasma pneumoniae*, *Chlamydia pneumoniae*, *Legionella pneumophila*.
- **Fisiopatologia:** mecanismo envolve a **microaspiração** de secreção contaminada de orofaringe e nasofaringe colonizada por microrganismos patogênicos.
- **Quadro Clínico:** febre, dor torácica (pleurítica), **tosse (80% dos casos)**, **expectoração purulenta/amarelada (50% dos casos)** e **dispneia subjetiva (50 a 70% dos casos)**; pode ocorrer também mialgia, sudorese noturna e taquicardia.



PNEUMONIA

- A abordagem do paciente com pneumonia comunitária (PAC) deve ser sistematizada. O uso de ferramentas de **estratificação de gravidade** auxilia na definição de como deve ser conduzida a terapêutica do paciente.
- Quais ferramentas podemos utilizar? **PSI/PORT (Pneumonia Severity Index) e Escore CURB-65 (ou CRB-65).**



PNEUMONIA

CURB-65

- **C:** Confusão mental (Glasgow < 15).
- **U:** Ureia > 43mg/dL ou > 50 mg/dL.
- **R:** Frequência respiratória > 30 irpm.
- **B:** PA sistólica < 90 mmHg ou PA diastólica ≤ 60 mmHg.
- **65:** Idade ≥ 65 anos.

(Cada critério positivo: +1 ponto).

Interpretação racional: ↑ pontuação = ↑ mortalidade.

0 a 1: Considerar tratamento ambulatorial.

2: Considerar internação em enfermaria.

3, 4 ou 5: Internação (incluindo até UTI, se maior gravidade).



ROTINA CLÍNICA

PNEUMONIA

CRB-65

- **C:** Confusão mental (Glasgow < 15).
- **R:** Frequência respiratória > 30 irpm.
- **B:** PA sistólica < 90 mmHg ou PA diastólica ≤ 60 mmHg.
- **65:** Idade ≥ 65 anos.

(Cada critério positivo: +1 ponto).

Vantagem: Não depende de exame complementar.

0: Considerar tratamento ambulatorial.

1-2: Considerar internação em enfermaria.

3 ou 4: Internação (incluindo até UTI, se maior gravidade).



ROTINA CLÍNICA

PNEUMONIA

- **PSI/PORT (Pneumonia Severity Index):**

Tabela 4. Escore PSI – Avaliação completa	
Etapa 1	
Variável analisada	Pontos
Dados demográficos	
Idade	Homem = idade Mulher = idade – 10
Residência em asilo	10
Co-morbidades	
Neoplasia	30
Doença hepática	20
Insuficiência cardíaca congestiva	10
Doença cérebro-vascular	10
Doença renal	10
Exame físico	
Sensório alterado	20
FR>30 irpm	20
PAS<90 mmHg	20
Temp. axilar < 35 ou > 40°C	15
FC>125 bpm	10
ETAPA 2	
Variável analisada	Pontos
Exames complementares	
pH arterial<7,35	30
Uréia>78 mg/dl	20
Sódio<130 mEq/l	20
Glicose>250 mg/dl	10
Hematócrito<30%	10
PaO ₂ <60 mmHg	10
Derrame pleural	10
Total	Soma dos pontos



PNEUMONIA

PSI/PORT

Ferramenta com **maior poder discriminatório** em termos de mortalidade.

Avalia critérios demográficos, comorbidades, achados do exame físico e de exames complementares.

≤ 70 pontos: Considerar tratamento ambulatorial.

71 a 90 pontos: Considerar internação breve.

≥ 91: Internação (incluindo até UTI, se maior gravidade).



ROTINA CLÍNICA

PNEUMONIA

- É necessário decorar os scores? **Não!** Existem diversas ferramentas (incluindo gratuitas) nas quais preenchemos os dados, sendo possível obter o resultado do score do paciente de forma prática e rápida. Basta digitar o nome do score em uma ferramenta de busca e você pode acessá-los!
- **Lembrar:** score **sugere** a conduta. Cabe ao médico assistente entender o contexto do paciente e se atentar para alterações clínicas que não são avaliadas nessas ferramentas. **Exemplos:** Presença de hipoxemia*, paciente incapaz de ingerir medicação pela via oral, “insuficiência familiar”, dentre outras situações.



REFERÊNCIAS

- Infecções de vias aéreas superiores – Medicina de Emergência USP 17ª Edição.
- The common cold in adults: Treatment and prevention - UpToDate.
- Acute sinusitis and rhinosinusitis in adults: Clinical manifestations and diagnosis - UpToDate.
- Pneumonia adquirida na comunidade – Medicina de Emergência USP 17ª Edição.

